ICUの臨床倫理と終末期の意思決定

価値観を聴いてから、医師が提案する

聖路加国際病院 集中治療科

今日持ち帰る3つ

1

DNARは、心停止時のCPRだけを決める
治療の範囲は多職種の検討と共同意思決定で決め、迷えば期限付きで試す

2

価値観を聴いてから、医師が推奨する
選ばせない。決定の重荷を家族に負わせない

3

終えるときは、苦痛に先回りする
緩和ケアを先に準備し、家族とチームを支える

はじめに

倫理は、
毎日の判断の中にある

特別な症例のときだけの話ではない

聖路加国際病院 集中治療科

この聞き方、していませんか

「心臓マッサージは希望しますか」

価値観を聴く前に、処置の希望を聞く

「DNARなので挿管はしません」

心停止前の治療まで、自動的に控える

「ご家族で決めてください」

決断の重さを、家族に預けてしまう

どれも悪意はない。**聴く順番と、DNARの範囲**がずれている

第 1 章

01

前提をそろえる

なぜ大事か・言葉・中心原則

ICUの死の多くは、「決めた後」に起きる

89.7%

治療制限を伴う死
（1999年は68.3%）

20.4%

治療制限を受けた後に、
生存して退院（同 5.5%）

34.9%

差し控えた後に限ると、3人に
1人が退院

治療制限は看取りの開始ではなく、ゴールの定義し直し。決め方が結果を左右する

出典：Ethicus-2（Sprung JAMA 2019、欧州22 ICU・2015〜16年）

2026年の基準線は、手順で決めること

項目	2014年（3学会の提言）	2026年（4学会合同GL）
終末期	定義し、4つの例示	**あえて定義しない**
決め方	チームが終末期と判断	多職種の検討＋共同意思決定
差し控えと終了	—	倫理的に同等。TLTを明記
緩和ケア	「緩和的措置」の一言	別編で薬・家族・医療者のケア

法律はない。手順を踏み、過程を記録することが法的な不安への答え

出典：4学会合同ガイドライン（2026）本編・説明文

同じ言葉を、同じ意味で使う

用語	定義・使い方	避ける言い方
DNAR	心停止時にCPRを試みない指示。 **心停止時だけ**有効	「急変時DNR」
差し控え／終了	始めない／やめる。倫理的に同等	「治療中止」
終末期	4学会GLは定義しない。ゴールから判断する	「終末期なので」
推定意思	本人ならどう考えるか。家族の希望と区別する	「家族がDNARを希望」
BSC・延命治療	使わない。何を続け、何を終えるかを書く	「BSCで」

出典：4学会合同ガイドライン（2026）、日本集中治療医学会 DNAR勧告（2017）、日本救急医学会 用語の統一概念（2025）

中心原則：選ばせずに、医師から提案する

相手に選ばせず、医師から提案する。

ただし、状況に応じて提案の強さを変える。

1
病状を伝える

→

2
価値観を聴く

→

3
専門家として
推奨する

出典：Lu E, Mayo Clin Proc 2020（3ステージ）、AHA 2025 倫理編

提案と誘導を分けるのは、価値観を聴いたかどうか

価値観を聴かずに	→	「CPRはしないほうがいい」	→ 誘導
価値観を聴いた 「もう苦しみたくない」	→	「CPRはしないほうがいい」	→ 提案

同じ言葉でも、順番で意味が変わる。提案は**価値観を医療行為に翻訳**すること

出典：Lu E, Mayo Clin Proc 2020、Elwyn BMJ 2010

提案の強さは、5段階

●●●●●	**informed assent**	**「○○はしません」**	無益が明らかで、 価値観もはっきり
●●●●○	**informed nondissent**	**「反対があれば、おっしゃってください」**	拒否権を明示して残す
●●●○○	**推奨して意見を求める**	**「しないほうがいいと思います」**	推奨ははっきり、 決定は一緒に
●●○○○	**やや弱い推奨**	**「おすすめしません」**	医学的な見込みに幅が あるとき
●○○○○	**使わない**	**「○○はどうしますか」**	ゴールに 寄与しないなら、 丸投げになる

強い：医療者が重さを引き受ける　　弱い：決断を相手に預ける

出典：Curtis JAMA 2020（informed assent）、AHA 2025 倫理編（informed nondissent）

強さを選ぶ、3つの要素

1

医学的な確かさ
利益がないことが、どこまで明らかか

2

価値観の明確さ
本人が何を大切にするかが、聴けているか

3

委ねたい気持ち
家族が決定を医療者に委ねたいか。**強い形の前に確かめる**

そろわなければ強さを下げる。提案の前に聴き直す

出典：AHA 2025 倫理編、Curtis JAMA 2020

第 2 章

02

誰がどう決めるか

枠組み・意思決定能力・2本柱

4原則は、ぶつかる価値に名前をつける

自律尊重

本人が自己決定する権利

例：本人が挿管を拒む、事前指示がある

善行

本人に最大の利益をもたらす義務

例：見込みの不確かな治療を始めるか

無危害

利益のない治療で害を与えない義務

例：苦痛を伴うだけの処置、無益なCPR

公正

すべての患者を公平に扱う義務

例：ベッドの配分、障害や年齢による無自覚な差

「全部やって」は、家族の希望と無危害がぶつかっている、と言い換えるだけで議論が進む

出典：FCCS（倫理の章）

4分割法で、症例をもれなく並べる

医学的適応
診断と予後、治療の目標、成功の可能性、
失敗したときの対応

患者の意向
本人の希望、意思決定能力、事前の意思表示、
代理は誰がどの基準で

QOL
元の生活に戻る可能性、評価者のバイアス、
緩和ケアの予定

周囲の状況
家族、医療者側の問題、経済・宗教・文化、
資源、法律

4つの窓を全部埋めてから議論する。埋まらない窓が、次に集める情報

出典：Jonsen の4分割表。4学会GLの「臨床倫理的検討の4観点」も同じ骨格

意思決定能力は、決定ごとに評価する

① 選択を伝えられる

② 理解する

③ 自分のことと
して認識する

④ 比較して考えられる

- 全か無かではない。**医学的助言に反する選択**だけでは能力欠如の根拠にならない
- 鎮静・せん妄で能力は時間で動く。**清明な時間**に合わせる
- 「能力なし」とだけ書かず、決定・時刻・欠けた過程を書く

出典：Ganzini JAMDA 2004、4学会合同ガイドライン（2026）Q16

一人で決めない：2本柱で検討し、3つから選ぶ

柱1 チームの臨床倫理的検討

4観点をもれなく。関わる診療科・多職種・かかりつけ医まで、**全員に発言の機会**を

柱2 本人・家族等との共同意思決定

厚労省プロセスガイドラインに沿う。価値観を聴いてから推奨する

差し控え
始めない

終了
症状緩和のみ、または一部

TLT
期限付きで試す

決まらなければ倫理コンサルへ。ただし決定は代行させない

出典：4学会合同ガイドライン（2026）。どれを選んでも心停止時のCPRは行わず、症状緩和は続ける

代理の人には「ご本人ならどう言うか」を聞く

場面	進め方
本人の意思を確認できる	能力を評価し、説明して合意する
確認できないが推定できる	家族等とチームが推定した意思を尊重する
推定もできない	家族等と話し合い、本人にとって最善の方針をとる。状態が変わるたびに繰り返す
身寄りがない	過去の意向を最大限尊重し、チームと倫理委員会が透明な手続きで判断する

> **問うのは「ご家族はどうしたいか」ではなく「ご本人ならどう考えるか」**

出典：厚労省プロセスガイドライン（2018）、4学会合同ガイドライン（2026）Q6・Q18

予後の数字は情報、決定は価値観で

「偽陽性ゼロ」でも

10.6%

良好転帰が33例なら、真の偽陽性率は95%の確からしさで**ここまで**しか言えない

「反応がない」でも

15〜25%

急性脳損傷で反応のない人に、検査でしか分からない**隠れた意識**がある

重症度スコアや予後モデルを、治療制限の理由としてカルテに書かない

出典：Bein ICM 2023、Xu Crit Care 2026、Cho Crit Care 2026、Egawa J Intensive Care 2024

違和感と先入観を、チームで点検する

26%

「不適切な治療をしている」と感じていた医療者。複数人が一致した患者は6か月死亡

aOR 3.86

違和感は予後のシグナル。ゴールを見直すきっかけにする

18% 医療者の予想　**92%** 生存者本人

重い脊髄損傷のあと「生きていてよかった」。医療者の推定するQOLはあてにならない

「この人はどうせ」を前提にしない。本人に聞く

出典：PICNL-ICU（CCM 2026、オランダ47 ICU・1,058人）、Gerhart Ann Emerg Med 1994、Taccone ICM 2023

第 3 章

03

聴いてから話す

ACP・面談の型・家族の重荷

ACPとGoals of Care

選択肢から始めると、生死の二択になる

先に、何を大切にしてきたかを聴く

聖路加国際病院 集中治療科

病状 → 価値観 → 推奨の3段で話す

Stage 1
病状を伝える
予後をはっきりと。
医療者が主

→

Stage 2
価値観を聴く
楽しみ・生きがい・
悪くなったときの気が
かり。**本人・家族が主**

→

Stage 3
推奨する
価値観を医療行為に
翻訳して提案。
医療者が主

いちばん多い失敗は、Stage 2 を飛ばして Stage 3 の選択を迫ること

出典：Lu E, Mayo Clin Proc 2020、Secunda J Gen Intern Med 2020

ACPは書類ではなく、価値観の共有

48%

事前指示書が効く7条件が、それぞれ**90%**で
そろっても、全部そろう確率

- 書類が「もう話さなくてよい」を
  生むこともある
- 根幹は、本人が価値観を言えること
- 代理人1人より、**多くの
  家族と共有**しておく
- ICUの制限カンファで事前指示があった
  患者は**0名**

ACPは、イベントではなく繰り返すプロセス

出典：厚労省GL 2018、Auriemma JAMA Intern Med 2022、Tarcy ICM 2022、『あなたのACPはなぜうまくいかないのか？』

入院時は、推定意思の確認にとどめる

入口	蘇生の可否は聞かない。「**何か伺っていますか**」と、大事にしてきたこと・望まないことを聴く
指示簿	「暫定フルコード（状況により随時検討）」と書き、話し合いの**進捗**を残す
経過の中で	悪化の兆し・家族の問いで話し合い、**範囲の明確なDNAR**に落とす

出典：厚労省プロセスGL（2018）、4学会合同ガイドライン（2026）

どう話すか

知らせの直後に、決めさせない

混乱や沈黙は、生理的な過負荷のサイン

聖路加国際病院 集中治療科

面談は5段階：説明の前に聴き、推奨は最後に

1 目的を伝え、許可を得る	「大切なことを伺いながら、一緒に考えたいのですが、よろしいですか」
2 理解と心配を聴く	「今一番心配なことは、どのようなことですか」
3 見通しを伝える	「残された時間が日単位〜週単位になっている可能性を心配しています」
4 大切なことを聴く	「普段の生活で一番楽しみにしていることは何ですか」
5 本人の言葉で推奨する	「○○が大切とおっしゃいましたね。それを考えると、◎◎をお勧めします」

淡い段は、こちらが話す前に聴く段。本人に意識があれば、家族より先に本人に聞く

出典：4学会合同ガイドライン（2026）緩和ケア別編（言い方は要旨）、Kentish-Barnes ICM 2023

予後は「わかりません」で済ませず、時間の単位で

「正確には分かりません。ただ、目安はお伝えできます」

数時間〜数日	**数日〜数週**	数週〜数か月	数か月〜数年

- 聞く準備ができているかを先に確かめる
- 伝えたら**沈黙を置く**。気まずさから話し足さない

出典：『あなたのACPはなぜうまくいかないのか？』、4学会合同ガイドライン（2026）緩和ケア別編

決定の重荷を、家族に負わせない

言わない

「決めたのはご家族です」

こう言う

「医学的な結論を、ご家族と確認しました」

- 「死のタイミングに関わった」という**決定の残滓**は、正しい説明でも消えない
- 家族に選んでもらうのは、誰がそろうか・何時にするか。**良い記憶**として残る

出典：Choi Crit Care 2026、Kentish-Barnes ICM 2026

節目の面談と、議題のない日々の声かけ

	公式の家族面談	日々のcheck-in
いつ	入室早期・TLTの期日・方針を変えるとき	毎日、面会のたびに数分
議題	あり。5段階を順に踏む	なし。**聴くことに徹する**
出てくること	予後・方針・介入の可否	お金・仕事・症状など医療の外の困りごと

出典：Ashana ICM 2026、Cox CCM 2023

対立は3層で見立て、関係の層に入る前に手を打つ

課題

「透析は続けるべきだ」
何をすべきか。情報と
選択肢を整理する

→

プロセス

「そんな話、
聞いていません」
誰がどう決めたか。
決め方と決定者を
明らかに

→

関係

「この病院は
信用できない」
信頼が壊れた。
第三者が要る

「困った家族」と呼ぶ前に、どのプロセスが壊れていたかを見る

出典：Jabaley Crit Care 2026、出典：4学会合同ガイドライン（2026）緩和ケア別編

第 4 章

04

DNARと蘇生

範囲は心停止時だけ。事前に決める

DNAR

DNARは、
心停止時のCPRだけを決める

ほかの治療は、別に話し合って決める

聖路加国際病院 集中治療科

DNARで決まること、決まらないこと

決まること	心停止時に、胸骨圧迫・除細動・気管挿管などの**蘇生を試みない**
決まらないこと	心停止前の挿管・人工呼吸・昇圧薬・血液浄化・ICU入室。目標と価値観に照らして**一つずつ**決める
必ず行うこと	抗菌薬・酸素・非侵襲的換気・鎮痛鎮静・補液。DNARの有無にかかわらない
しないこと	入院時の一律のDNAR、部分的DNAR（「心マだけ」）、スローコード

> **「心停止」を「急変時」にすり替えない**

出典：日本集中治療医学会 DNAR勧告（2017）、日本救急医学会 用語の統一概念（2025）、4学会合同GL Q37・Q39

「原疾患の心停止だけ」は成り立たない

反論①

心停止の原因は、その場では**分からない**。
発見するのは多くが看護師

反論②

DNARの根拠の多くは「CPRの利益がない」
という見込み。原因が分からなくても
見込みは変わらない

文書の根拠

原疾患に限ると定めた学会文書は
見当たらない。別の原因での心停止は
事前に話し合えとあるだけ

出典：日本集中治療医学会 委員会報告（2016）、AHA 2025 倫理編

フレイルは材料であって、結論ではない

医学の問い

蘇生がうまくいくか

- フレイルでCPR後死亡 OR 3.56（7研究）
- CFS 4超で生存退院 0／90例中
- CFSが高いほど神経学的転帰が悪い（日本）

価値の問い

この人にとって蘇生が最善か

- フレイルは答えない
- 年齢を唯一の決定因子にしない
- 価値観を引き出す方法がSDM

閾値は研究ごとに違い、一律の線は引けない

出典：Hamlyn Resusc Plus 2022、Ibitoye Age Ageing 2021、Yamamoto Ann Emerg Med 2023、AHA 2025 倫理編

価値の判断は事前に、現場では指示に従う

看護師（発見者）

- その場で価値観に立ち返らなくてよい
- 範囲が明確な指示に従う
- 曖昧で迷ったら、**蘇生を始めながら確認**

医師

- 事前に、価値観を聴いてから推奨する
- はい／いいえで選ばせない
- 結果を**範囲の明確な指示**にしておく

出典：AHA 2025 倫理編

窒息と医原性の心停止は、事前に合意した範囲で

窒息の苦しさ	異物除去や吸引はCPRではない。DNARと無関係に行う
窒息後の心停止	CPRをするかは、原因ではなく**事前に合意した範囲**で決まる
処置に伴う心停止	可逆的で、処置への同意に回復が含まれうる。処置中にDNARを一時解除するかを**事前に決める**

指示は「原因を問わず・窒息を含む・処置は事前に」と範囲で書く（文例は最後の章）

出典：日本集中治療医学会 委員会報告（2016）。範囲の書き方は一般論としての実装の一案

「すべて」は、処置に降ろして話す

82.4%
スローコードを「欺瞞」と判断した倫理文献

67.6%
「患者への害」と判断

61.8%
無益なCPRは断ってよい

- 「すべてやりますか」ではなく、「**胸骨圧迫・挿管・電気ショック**は、この方の目標の役に立つでしょうか」
- 短時間だけのCPRも、倫理的な妥協にならない

出典：Fontenot CCM 2026、Wasserman Crit Care 2026

第 5 章

05

差し控え・終了と緩和的抜管

同じ問いに答え、苦痛に先回りする

差し控えと終了は、同じ問いへの答え

その治療は、いまの時点で本人にとって適切か

まだ始めていない → 差し控え

差し控えた後、**3人に1人**は生きて退院

すでに始めている → 終了

終了した後、**98%**が24時間以内に亡くなる

**倫理的に同等。「やめられないから始めない」を
しない。臨床経過は別物なので記録で書き分ける**

出典：4学会合同ガイドライン（2026）Q33・Q34、Ethicus-2（Sprung JAMA 2019）

3つの対応で、行うことと行わないことを分ける

対応	行うこと	行わないこと
差し控え	症状緩和の治療とケア	新たな治療の開始と増強
終了	鎮痛・鎮静薬を続けて調整する	呼吸器・補助循環・昇圧薬・ 透析などを、**一つずつ**終える
TLT	合意した期間、治療を試す	期限で**自動的に**終了も 延長もしない

どれを選んでも症状緩和は最大限続け、心停止時のCPRは行わない

出典：4学会合同ガイドライン（2026）。強心薬・人工栄養・ペースメーカーも、何のために使っているかで一つずつ決める

TLTは、目標・期日・価値観を先に書く

目標
人工呼吸から
離れて、
会話できる
状態に戻る

→

期日と指標
7日目に、
離脱の可否と
意識レベルで

→

価値観
「家族と
話せない状態で
長く生きる
ことは
望まない」

→

**期日で
立ち止まる**
改善なら継続、
未達なら終了も
含めて話す

曖昧なまま続けると「決めきれないから続ける」になる。TLTは免罪符ではない

出典：4学会合同ガイドライン（2026）Q35、Quill JAMA 2011

緩和的抜管

準備を済ませ、苦痛に先回りする

緩和ケアは、終了の前から始まっている

聖路加国際病院 集中治療科

抜管の前日から、時刻を逆算する

24時間前	12時間前	2時間前	30分前	直前	抜管後
経管栄養を止める 前日までに終えておく	**上気道浮腫が心配なら** メチルプレドニゾロン 20 mg 4時間おき	**筋弛緩薬を止める** 多臓器不全では18時間前	**分泌物が予想されたら** ブチルスコポラミン 10〜20 mg 皮下注	**苦痛に先回り** オピオイドと鎮静薬の事前投与	**そばを離れない** 落ち着くまで医師・看護師が調整

筋弛緩薬が残っていると、苦しんでいても外から分からない

出典：4学会合同ガイドライン（2026）緩和ケア別編。12時間前・30分前・直前の投与は必要な患者に

死亡までは数分〜数日と、幅を持たせて伝える

段階的離脱

- 15〜30分かけて設定を下げ、自発呼吸へ
- 高度のサポートが要る呼吸不全で多い

即時抜管

- 準備を済ませ、設定を下げずに抜管
- 意識障害の患者で多い

- 死亡までは**数分から数日**と幅を持たせて伝える
- 死戦期呼吸・筋の攣縮・「思ったより長くかかること」を**先に言葉にしておく**

出典：4学会合同ガイドライン（2026）緩和ケア別編、Kentish-Barnes ICM 2026

薬はボーラスで効かせ、オピオイドに上限を設けない

場面	モルヒネ	フェンタニル	ミダゾラム
未投与の初回	2〜5 mg 静注・皮下	20〜50 μg	0.01〜0.06 mg/kg
持続中の抜管直前	直近の効果量の2倍	直近1時間量の 25〜50%	持続の1時間量
抜管後に苦しそう	10〜15分ごとに追加	5〜10分ごとに追加	5〜10分ごとに追加

頻回に要るなら持続を始める・増やす。増量の意図は滴定のたびに記録する

出典：4学会合同ガイドライン（2026）緩和ケア別編 表1（米国の記事の改変・日本の用量の根拠ではない）。患者ごとに調整

症状を予測して、初手を先に打つ

初手

- 呼吸困難・痛み → オピオイドのボーラス
- 不安 → ミダゾラム
- 過活動型せん妄 → 抗精神病薬
- 気道分泌物 → 体位と輸液の減量。
  家族への説明を添える
- 上気道狭窄 → 抜管前のカフリークテスト

しないこと

- 不安・せん妄に、鎮静目的のオピオイド
- 深い吸引（口腔内など浅く、愛護的に）
- 筋弛緩薬を残したまま抜管する

出典：4学会合同ガイドライン（2026）緩和ケア別編

第 6 章

06

看取り・チーム・公正

家族の時間を守り、医療者を守る

看取りと死別

最期の時間を、家族とともに守る

決める前から、亡くなった後まで

聖路加国際病院 集中治療科

家族のケアは、6つの時期で考える

1

話し合いの前
人となりを
聞き、
休める場を

2

話し合いの間
ずれは
否定せず、
様子を見て
もらう

3

話し合いの後
迷いは当然と
伝える

4

終了の前
数分〜数日と
幅を伝える

5

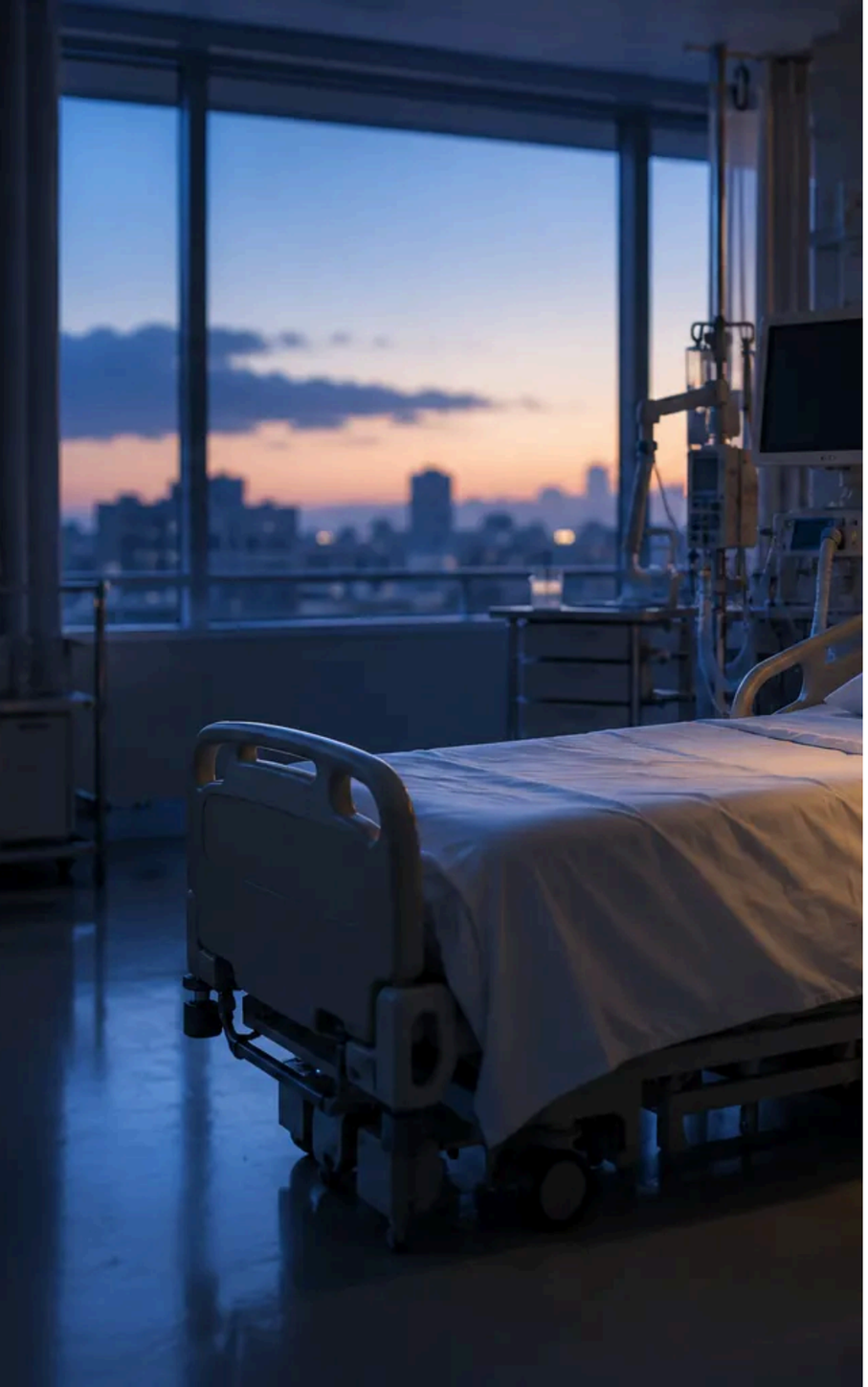
臨終時
音・におい・
汚れを整える

6

死別後
1〜2週後の
電話を検討

死の前後に会う支援で、遷延性悲嘆が21%→15%。差の実体は死後の面談

出典：4学会合同ガイドライン（2026）緩和ケア別編、Kentish-Barnes Lancet 2022



死の判定と臓器提供は、手順を分ける

死亡確認	確かめているのは「戻せない」ではなく 「**もう戻さない**」という決定
順序	終了の判断が先、臓器提供の提示は後。 提供の可能性で終了を決めない
家族	死亡告知と提供の依頼を**同じ** **面談に入れない**
脳死の言葉	「臓器を支える治療」と言い換え、 判定への立ち会いを選べるようにする

出典：Le Dorze・Choi Crit Care 2026、4学会GL Q79、Wu JAMA 2026

モラルディストレスは、組織の課題

増やす要因

- 「ノーと言えない」病院文化
- 医療の階層
- 治療を足す手続きはあるのに、**減らす手続きがない**

先に変える順番

- 看護師が単独で倫理・緩和コンサルを頼める
- 家族面談に看護師が同席する
- 終了条件を書面に残す
- **その次に**
  デブリーフィング

デブリーフィングは緩和であって予防ではない。
書式を整えるだけでは風土は変わらない

出典：Brender JAMA Netw Open 2025、CODE ICM 2024、4学会GL別編

年齢や障害で推し量らず、本人に尋ねる

1. 「普段使っているコミュニケーション手段は」
2. 「入院前は、何ができる状態でしたか」
3. 「この推奨は、**障害がなかったとしても同じ**ですか」

ベッド状況・「無益性」・予後モデル・
障害だけを、判断の根拠にしない

出典：Taccone ICM 2023、4学会GL Q47・Q70〜Q76、Beil ICM 2026

第 7 章

07

落とし穴と記録

結論だけでなく、範囲と過程を残す

良い意図が、言葉と順番の誤りで害に変わる

よくある言葉・行動	代わりに
DNARを理由に、心停止前の治療を控える	挿管・昇圧薬・ICU入室は別に話し合う
「やめられないから始めない」	迷ったらTLTで始め、期日に見直す
知らせの直後に「どうされますか」	その場で決めさせず、翌日もう一度話す
「決めたのはご家族です」	「医学的な結論をご家族と確認しました」
筋弛緩薬を残したまま抜管する	2時間前までに止め、苦痛に先回りする
死亡告知と提供の依頼を続けて話す	間に時間を置き、担当を分ける

まだ分からない：4学会GLの手順が、患者・家族のアウトカムを改善するか

出典：4学会合同ガイドライン（2026）ほか

カルテ記載

結論だけでなく、範囲と過程を残す

DNARの有無だけでは、夜勤に伝わらない

聖路加国際病院 集中治療科

文例1：DNAR指示は、範囲で書く

【コードステータス】DNAR（心停止時に心肺蘇生を試みない）

- 適用範囲：心停止の原因を問わず、胸骨圧迫・除細動・気管挿管・蘇生薬投与を行わない。窒息による心停止を含む。
- 例外：**[内視鏡／CV挿入など]** 処置に伴う心停止の扱いは処置前に確認
- DNARを理由に控えない治療：酸素、輸液、抗菌薬、昇圧薬、**[NIV]**
- 心停止前の治療（別に決定）：挿管 **[行う／行わない／TLT]**、透析 **[…]**
- 再評価：**[病状が変化したとき／○月○日／処置の前]**

［ ］は症例ごとに書き換える。施設の様式に合わせて直す

一般論としての文例。4学会GLが求める記録項目に沿う

文例2：面談記録は、過程を残す

1. 病状の説明
   見通し［数日〜数週］
   理解：「［家族の言葉］」
2. 本人の価値観
   「［本人の言葉・逐語］」
   推定の根拠：［以前の会話］
   → ゴール：［…］

3. 推奨と合意
   CPRを行わないと推奨
   形：［assent／nondissent］
   反応：［異議なし／保留］
4. 4観点の検討
5. 決定・保留・再評価日

一般論としての文例。参加者（本人・家族等・医師・看護師・ほか）と、検討に加わった全員も書く

文例3・4：TLTと、本人の意思によるDNAR

文例3 TLT

目的：［会話できる状態に戻ること］
治療：［人工呼吸／CRRT］
期間：［7日間］ 再評価 ［○月○日］
評価項目：［酸素化・昇圧薬・意識］
改善しないとき：［終了を含め
ゴールに沿って話し合う］

文例4 本人の意思によるDNAR

本人 ［意思決定能力あり：
4つの過程を確認］
「［本人の言葉］」
本人の価値観に基づく選択として
心停止時のCPRを行わない
家族等 ［氏名］ と共有 ［済／未］

一般論としての文例。終末期でなくても、本人には生命維持治療を選ぶ権利がある（4学会GL）

「急変時DNR」「家族が希望」だけを書かない

「急変時DNR」「DNR取得」
範囲が曖昧で、治療全般を
控える読み方を招く

「家族がDNARを希望」だけ
価値観・推定意思の
根拠・推奨がなく、何を
合意したか残らない

重症度スコアを
制限の理由に
予測は共有した情報、決定は
価値観と合意として書く

DNAR指示の記録は9割、協議の過程の記録は7割（学会の調査）

出典：日本集中治療医学会 委員会報告（2016）、4学会合同ガイドライン（2026）

まとめ：選ばせずに、医師から提案する

価値観を聴いてから推奨する。強さは状況で変える。
提案と誘導を分けるのは、価値観を聴いたかどうか

1

「どうしますか」を、推奨に変える
病状 → 価値観 → 推奨。決定の重荷を家族に負わせない

2

DNARを範囲で書き、心停止前の治療は別に決める
迷えば目標と期日を決めてTLTで試す

3

終えるときは苦痛に先回りし、過程を記録に残す
一人で決めず、チームも家族も支える

ご清聴ありがとうございました

次の面談で、選ばせずに提案してみてください

聖路加国際病院 集中治療科

主な出典

- 日本集中治療医学会・日本救急医学会・日本循環器学会・日本緩和医療学会. 生命維持治療の終了／差し控えに関する4学会合同ガイドライン（本編・説明文・Q&A集・緩和ケア別編）. 2026
- 厚生労働省. 人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン. 2018
- 日本集中治療医学会. DNAR指示のあり方についての勧告. 2017／委員会報告. 2016／日本救急医学会. 高齢者救急に関する用語の統一概念. 2025
- Elmer J, et al. Part 3: Ethics. 2025 AHA Guidelines for CPR and ECC. Circulation 2025
- Sprung CL, et al. JAMA 2019（Ethicus-2）／Curtis JR, et al. JAMA 2020／Lu E, et al. Mayo Clin Proc 2020／Secunda K, et al. JGIM 2020
- Ganzini L, et al. JAMDA 2004／Bein T, et al. ICM 2023／Taccone FS, et al. ICM 2023／Quill TE, et al. JAMA 2011
- Kentish-Barnes N, et al. Lancet 2022・ICM 2026／Jabaley CS, et al. Crit Care 2026／Choi・Le Dorze. Crit Care 2026／Wu. JAMA 2026
- Fontenot T, et al. CCM 2026／PICNL-ICU. CCM 2026／Brender TD, et al. JAMA Netw Open 2025／Hamlyn J, et al. Resusc Plus 2022
- 『あなたのACPはなぜうまくいかないのか？』メジカルビュー社 2024